UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ - CAMPUS MACAÉ

LARISSA FERREIRA VIANA

FINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: PANORAMA, REFLEXÕES E DESAFIOS (2015-2018)

MACAÉ
2024

LARISSA FERREIRA VIANA

FINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: PANORAMA, REFLEXÕES E DESAFIOS (2015-2018)

Trabalho de conclusão de curso (TCC) apresentado ao Curso de Farmácia do Instituto de Ciências Farmacêuticas da UFRJ, como requisito para obtenção do título de farmacêutico.

Orientadora: Prof. Dra. Isabella Piassi Dias Godói

MACAÉ

2024

CIP - Catalogação na Publicação

V614f

Viana, Larissa Ferreira
Financiamento da saúde pública no Estado do Rio de Janeiro: panorama, reflexões e desafios (2015 2018) / Larissa Ferreira Viana. -- Rio de Janeiro, 2024.
39 f.

Orientadora: Isabella Piassi Dias Godói.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Ciências Farmacêuticas, Bacharel em Farmácia, 2024.

1. Financiamento em Saúde. 2. Sistema Único de Saúde. 3. Gestão. 4. Rio de Janeiro. 5. Assistência Farmacêutica. I. Godói, Isabella Piassi Dias, orient. II. Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283.

LARISSA FERREIRA VIANA

FINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: PANORAMA, REFLEXÕES E DESAFIOS (2015-2018)

Trabalho de conclusão de curso (TCC) defendido e aprovado como requisito para obtenção do título de farmacêutico.

Macaé, 13 de junho de 2024.

Comissão avaliadora:

Profa. Dra. Isabella Piassi Dias Godói (Presidente da Banca)

CM UFRJ-Macaé

http://lattes.cnpq.br/9235375090080643

Profa. Dra. Rita Cristina Azevedo Martins

CM UFRJ-Macaé

http://lattes.cnpq.br/9368897588729263

Profa. Mestre em Ciências Jéssica Fernandes de Souza

Secretaria Municipal de Saúde

http://lattes.cnpq.br/7863037759290970

AGRADECIMENTOS

É com imensa gratidão que dedico este momento aos que estiveram comigo desde o início, oferecendo suporte, conselhos e encorajamento.

Aos meus queridos pais, Renata e Deiverson, dedico os meus mais sinceros agradecimentos por serem a fonte constante de apoio, incentivo e amor ao longo desta jornada. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo.

À minha irmã Izabelle, agradeço pela companhia, as incontáveis crises de riso e conversas profundas. Sua existência me incentiva a ser alguém melhor.

Aos meus amados avós, Marizia, Renandes, Maria José e José Carlos (*in memoriam*), sua presença em minha vida é uma benção que nunca deixarei de apreciar. Seu amor incondicional e seus ensinamentos valiosos moldaram quem sou hoje.

À minha prima Milena, sou imensamente grata por tê-la em minha vida. Encontrei em você uma fiel escudeira. Minha companheira de sempre e para sempre.

Aos meus tios, Marilda e Cláudio, agradeço pelo carinho e cuidado. Obrigada por serem tão especiais.

Aos meus amigos, Matheus, Laiz e Vinicius, obrigada por terem tornado tudo mais leve e divertido. Ter vocês ao meu lado durante essa jornada foi incrível.

À minha querida orientadora, Professora Dra. Isabella Godói, dedico meus agradecimentos acompanhados da minha admiração. Suas aulas reacenderam meu amor pelo curso de Farmácia e por isso, sou muito grata pela sua parceria, ensinamentos, conselhos e incentivos. Obrigada por ter acreditado no meu potencial desde o início dessa caminhada.

Também dedico um momento para agradecer a mim mesma por todo trabalho árduo e dedicação que investi ao longo deste caminho. Agradecer a si mesmo pode parecer incomum, mas reconheço que se não fosse a minha coragem de correr atrás dos meus sonhos, nada disso estaria se concretizando.

Por fim, agradeço a Deus, por todas as bênçãos e livramentos. “Toda honra e glória sejam dadas a Deus, cuja graça e bondade sustentam minha jornada e guiam meus passos.”

RESUMO

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) foi regulamentado a partir das chamadas Leis Orgânicas da Saúde nº 8.080 e nº 8.142 de 1990, que estabeleceram uma série de princípios e premissas a serem consideradas para a saúde no Brasil, incluindo o acesso aos diferentes níveis de atenção à saúde de forma universal e gratuita. Destaca-se a relevância de estudos e iniciativas aplicadas à transparência e a discussão do financiamento dos serviços em saúde. **Objetivos**: Apresentar a alocação de recursos públicos em saúde no Estado do Rio de Janeiro no período de 2015 a 2018, advindos do Fundo Nacional de Saúde, e demonstrar a importância da compreensão destes recursos. **Métodos**: Realizou-se um estudo quantitativo descritivo no segundo semestre de 2023, a partir da extração de dados referente ao período de 2015 a 2018 associados a alocação de recursos públicos para as diferentes áreas da saúde, disponíveis no portal do Fundo Nacional de Saúde, bem como dos registros nesta temática contemplados no Plano Plurianual (2016-2019), disponibilizados no Portal da Transparência do Estado do Rio de Janeiro. **Resultados e discussão:** Verificou-se um total executado de R$22.002.986.283,17 com a saúde, sendo destes R$480.758.737,56 alocados na Assistência Farmacêutica e R$4.428.294.397,74 na Atenção Básica, equivalente a 2,18% e 20,13%, respectivamente, do global registrado para a saúde no período avaliado, o que reflete os desafios e fragilidades para promoção de serviços tão essenciais promovidos pela Atenção Básica. No cenário da Assistência Farmacêutica, o valor previsto no Plano Plurianual para o quadriênio foi de R$621.551.730,00, porém executou-se R$571.802.443,20, o que correspondeu a 92%. O reflexo desse déficit pôde ser observado na diminuição do orçamento do Programa Farmácia Popular, que passou de R$5,2 milhões em 2015 para R$2,8 milhões em 2017. Ressalta-se que a Assistência Farmacêutica representou 2,18% dos recursos repassados pelo FNS ao Estado do Rio de Janeiro, 0,03% para Gestão do SUS, 3,57% com Vigilância em Saúde, 72,42% com Média e Alta Complexidade e 1,68% referente às atividades de Investimentos na Rede de Saúde, considerando o período de 2015 a 2018. Além disso, o Estado investiu, em média, 11,77% de sua receita líquida em ações e serviços de saúde entre 2015 e 2018, cumprindo o mínimo estabelecido pela LC nº 141 de 2012, exceto em 2016. Este desempenho razoável evidencia os desafios enfrentados pela saúde pública, como o sucateamento hospitalar e a escassez de medicamentos nas farmácias do governo. **Conclusão:** Alguns desafios e fragilidades foram observados neste estudo, considerando, por exemplo, o não cumprimento dos recursos previstos a serem destinados a Assistência Farmacêutica, bem como o baixo investimento aplicado a uma estratégica área do SUS, a Atenção Básica. Reforça-se, assim, a importância do debate sobre o financiamento dos serviços de saúde pública, visando promover reflexões sobre os desafios na alocação de recursos públicos na área da saúde, de modo a atender as demandas da população de forma mais eficaz.

Palavras-chave: financiamento em saúde; Sistema Único de Saúde; gestão; Rio de Janeiro; assistência farmacêutica.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Recursos públicos destinados à Assistência Farmacêutica pelo Fundo Nacional de Saúde para municípios do Estado do Rio de Janeiro (2015-2018)..... 23

Figura 2: Recursos públicos repassados do FNS as ações de Assistência Farmacêutica e ao Programa Farmácia Popular do Brasil no Estado do Rio de Janeiro (2015-2018)..... 24

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Demonstração dos recursos destinados à Atenção Básica no período de 2015 a 2018….....21

Tabela 2: Recursos destinados à Garantia da Assistência Farmacêutica no período de 2015 a 2018.....24

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Transferência de recursos públicos para a saúde no Estado do Rio de Janeiro entre 2015 e 2018.....20

Quadro 2: Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica no período de 2015 a 2018 do Estado do Rio de Janeiro.....22

LISTA DE ABREVIAÇÕES

SUS	Sistema Único de Saúde
FNS	Fundo Nacional de Saúde
PNI	Programa Nacional de Imunizações
LC	Lei Complementar
PIB	Produto Interno Bruto
CNS	Conselho Nacional de Saúde
PPA	Plano Plurianual
RREO	Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
PAB	Piso da Atenção Básica
QUALIFAR-SUS	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica
PNAISP	Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
ND	Não Disponível
SES-RJ	Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro
SIOPS	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
EC	Emenda Constitucional

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO **11**
2. JUSTIFICATIVA **14**
3. OBJETIVOS **15**
3.1 OBJETIVOS GERAIS 16
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16
4. MÉTODOS **17**
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO **19**
6. CONCLUSÃO **30**
7. REFERÊNCIAS **32**
8. APÊNDICE **39**

1. INTRODUÇÃO

Considerada um marco para a democracia brasileira, a Constituição Federal de 1988 foi responsável por promover o conceito de seguridade social ao estabelecer os direitos sociais como dever do Estado (BRASIL, 1988; PAIM, 2013). O reconhecimento do direito à saúde estabeleceu a necessidade para a discussão e planejamento de um conjunto de políticas públicas, incluindo a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), que visa à promoção, proteção e recuperação da saúde. O SUS é um sistema complexo com princípios como a regionalização, descentralização, hierarquização e participação popular, e atende mais de 200 milhões de indivíduos com o objetivo de garantir o acesso universal, integral e igualitário aos serviços de saúde (BRASIL, 1988; UNA-SUS, 2021). Considerando todas as suas premissas e objetivos, ao longo dos últimos anos têm sido realizados esforços direcionados para melhorar ações de planejamento e gestão dos serviços deste sistema, essencial a milhares de brasileiros, a fim de direcionar suas ações com foco no alcance dos resultados desejados (VIEIRA, 2009).

A regulamentação do SUS ocorreu a partir das chamadas Leis Orgânicas da Saúde nº 8.080 (BRASIL, 1990a) e a Lei nº 8.142 de 1990 (BRASIL, 1990b), que dispõem sobre a organização, funcionamento, planejamento e gestão deste sistema, e estabelecem a relevância da descentralização e pactuação das ações e serviços em saúde entre as esferas federal, estadual e municipal (ANDRADE, *et al*, 2013). Adicionalmente, muitos foram os programas, estratégias e iniciativas promovidas pelo SUS para a população brasileira como, por exemplo, ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) que desde a sua criação em 1973 tem contribuído para o cenário dos agravos infecciosos. Com destaque para a erradicação da varíola em 1973 e poliomielite em 1989, juntamente com as campanhas e demais estratégias deste importante programa, este tem auxiliado no controle e redução de infecções como as pneumocócicas, tétano acidental, coqueluche, hepatite B, influenza e sarampo. Nos seus mais de 50 anos de atuação, o PNI tem disponibilizado para toda a população cerca de 20 vacinas de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação e a partir de janeiro de 2024 incluirá no calendário de rotina a vacina contra a COVID-19 para grupos prioritários (BRASIL, 2023a; BRASIL, 2023b). Além disso, durante a pandemia do Coronavírus foram mais de 585,6 milhões de doses aplicadas, ação responsável pela redução de 96,44% de óbitos causados pelo coronavírus (ARAÚJO e FERNANDES, 2022; BRASIL, 2023). Ressalta-se que para atingir seus objetivos, o orçamento do PNI tem sido ampliado progressivamente, saindo de R$94 milhões em 1995 para R$4,3 bilhões em 2017 (HOMMA, *et al*, 2020).

Reforça-se que todos os serviços do SUS são financiados com recursos públicos, diretamente associado com a arrecadação de impostos envolvendo as três esferas de governo, municipal, estadual e federal. Sobre o financiamento das ações em saúde destaca-se a Lei Complementar (LC) nº 141 de 2012, que estabelece os valores mínimos a serem repassados por cada instância anualmente, no qual cabem a Municípios e Estados aplicarem respectivamente, 15% e 12% da arrecadação dos impostos, enquanto a União deve destinar o mesmo valor atribuído à saúde no ano anterior acrescido do percentual de variação do Produto Interno Bruto (PIB) (BRASIL, 2012).

No contexto do financiamento do SUS, além da LC nº 141 de 2012 (BRASIL, 2012) têm-se a Portaria nº 204 de 2007 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a criação de blocos de financiamento para otimizar a alocação de recursos, sendo estes: Atenção Básica, Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Gestão do SUS e Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (BRASIL, 2007). Dessa forma, os repasses financeiros entre as esferas governamentais eram realizados via Fundos de Saúde, de acordo com os blocos mencionados, permitindo maior rastreabilidades e fiscalização associado a cada uma das grandes áreas de alocação de recursos. Contudo, a partir da Portaria nº 3.992 de 2017 houve uma alteração passando de seis para apenas dois blocos, chamados de custeio das ações e serviços públicos de saúde e investimento na rede de serviços públicos de saúde (BRASIL, 2017; LINS, *et al*, 2021). Recentemente, ainda na temática do financiamento das ações em saúde, divulgou-se o chamado Piso Constitucional da Saúde, o qual o Conselho Nacional de Saúde (CNS) reivindica a ampliação do mínimo de 15% da receita corrente líquida a ser investida no setor nos próximos anos (BRASIL, 2023).

Nesta temática, ressalta-se a relevância do Fundo Nacional de Saúde (FNS), instituído pelo Decreto nº 64.867 de 1969, o qual colabora com as ações da gestão financeira associada aos recursos destinados a custear as despesas e investimentos do Ministério da Saúde e demais entidades vinculadas à administração direta e indireta do SUS. Dentre as suas competências está o planejamento, coordenação, execução e supervisão das atividades de convênios, prestação de contas e aplicação dos recursos transferidos ao SUS (BRASIL, 2024). O Portal do FNS permite consultar os repasses diários, pagamentos detalhados e consolidados, gráficos comparativos e saldo das contas correntes Fundo a Fundo, uma importante ferramenta para gestores, bem como para a comunidade (controle social)

(BRASIL, 2024). Fernandes e Pereira (2020) abordam a relevância deste portal, e indicam a confiabilidade dos dados obtidos, bem como a possibilidade de acompanhar os saldos e transferências detalhadas entre os fundos.

Outra estratégia de gestão de recursos é o Plano Plurianual (PPA) (BRASIL, 1988), um dos instrumentos de planejamento governamental de médio prazo que contempla as três esferas federativas. Nele são apresentadas as metas, ações e investimentos previstos para todas as áreas de governo, inclusive a saúde. O PPA é elaborado no primeiro ano de cada gestão e passa a vigorar no ano seguinte, se estendendo até o primeiro ano do mandato sucessor (BRASIL, 2019). Com o aumento progressivo dos gastos em saúde, destaca-se a importância deste instrumento regulatório para os estados e municípios, visto que passaram a compartilhar da responsabilidade de implementar políticas públicas, em contraste ao modelo anterior, centralizado na União (LIMA, *et al*, 2020; SILVEIRA e GAIGER, 2021). Essa ferramenta permite identificar os objetivos e prioridades do governo, nas suas respectivas esferas, além de integrar o planejamento ao orçamento, promovendo uma gestão mais eficiente (BRASIL, 2019). Neste cenário, a fim de monitorar o desempenho das ações planejadas, são elaborados os Relatórios de Acompanhamento de Ações Realizadas (BRASIL, 2000), documentos informativos que detalham sobre a implementação e o progresso das ações previstas no PPA. Estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 2000 (BRASIL, 2000), eles auxiliam na avaliação contínua e transparente das metas e atividades governamentais, a fim de garantir que as ações propostas estejam alinhadas com os objetivos definidos para o mandato (BRASIL, 2021).

Considerando que o SUS é um sistema público e universal, alguns estudos apontam que os gastos privados ultrapassam os gastos públicos em saúde (PIOLA, *et al*, 2013; FIGUEIREDO, *et al*, 2018). Figueiredo e colaboradores (2018) demonstram que dentre os países que possuem sistema público de saúde, o Brasil é o que menos investe nesta importante área (FIGUEIREDO, *et al*, 2018). O Reino Unido, por exemplo, investiu cerca de 8% do seu PIB em saúde, enquanto no Brasil esse percentual cai para 3,9% no ano de 2014. Além disso, reforçam ser imprescindível o desenvolvimento de análises do financiamento do SUS, em todas suas esferas, a fim de melhor entender o perfil do gasto em saúde em todo país.

Neste contexto, registra-se que ainda são poucas as publicações no cenário da alocação e/ou perfil das transferências de recursos públicos em saúde no cenário nacional (FIGUEIREDO, *et al*, 2018; UGÁ, *et al*, 2003; UGÁ, *et al*, 2012; BRITO e SOBREIRA,

2019), e algumas direcionadas ao Estado do Rio de Janeiro (LIRA, 2010; BENEVIDES, 2010). Em estudo sobre as condições de financiamento do SUS no Estado do Rio de Janeiro, Lira (2010) aborda o protagonismo dos municípios, visto que a principal fonte de recursos é a receita própria municipal e a participação do Estado no período do estudo ficou abaixo do percentual de 12% previsto na Lei. Adicionalmente, o autor destacou também a heterogeneidade na capacidade de gastos em saúde dentre os municípios do território, acentuando a desigualdade no acesso aos serviços de saúde no Estado. No tocante à alocação dos recursos próprios estaduais, o autor aponta que o Estado do Rio de Janeiro opta por custear as ações assistenciais nas unidades estaduais, em vez de investir em serviços que ampliem a capacidade de atendimento da população.

O Estado do Rio de Janeiro possui cerca de 16 milhões de habitantes e apresenta uma relevância socioeconômica no cenário nacional, sendo caracterizado como o segundo maior ente federativo em termos de participação no PIB brasileiro, e representou 10,8% em 2018 (CEPERJ, 2020). Apesar de um período de recessão, majoritariamente relacionado à instabilidade política e a crise sanitária da pandemia do Coronavírus (TRECE, 2022), o Rio de Janeiro tem apresentado uma recuperação da atividade econômica desde 2021, conforme indica o Boletim de Acompanhamento Fiscal de 2022 divulgado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (SINFRERJ, 2022). No mesmo ano, o Estado investiu, aproximadamente, R$8 bilhões em saúde, aplicando pelo segundo ano consecutivo o mínimo constitucional de 12% (SES-RJ, 2022), o que ainda espera ser aumentado mediante as muitas demandas verificadas em saúde pela população fluminense. Em face do exposto, denota-se a relevância da condução de estudos que analisem o perfil de alocação de recursos em saúde neste Estado.

2. JUSTIFICATIVA

O financiamento da saúde pública é uma questão de grande relevância, particularmente em contextos complexos como o Estado do Rio de Janeiro, onde os desafios econômicos, sociais e políticos apresentam potencial de influenciar diretamente a disponibilidade e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população. O Estado possui cerca de 16 milhões de habitantes e apresenta uma relevância socioeconômica considerável para o país, o que pode ser verificado a partir de dados que o caracterizam como o segundo Estado com maior participação no PIB brasileiro (SILVA, 2017). Ressalta-se que, no período deste estudo, entre 2015 e 2018, o Estado do Rio de Janeiro enfrentou uma série de desafios aplicados ao financiamento da saúde pública, refletindo não apenas as demandas imediatas da população, mas também as dinâmicas político-econômicas que moldam as ações de saúde.

Apesar da importância desta temática, observa-se uma escassez de publicações na área para as diferentes esferas de governo (federal, estadual e municipal) no Brasil. Em uma análise das condições de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Rio de Janeiro, Lira (2010) enfatiza que a contribuição do Estado durante o período do estudo permaneceu abaixo do limite legal de 12% e destaca a disparidade na capacidade de gastos em saúde entre os municípios, o que intensifica as desigualdades no acesso aos serviços de saúde no Estado, sendo essencial a promoção de estudos que melhor avaliem a distribuição e, principalmente, a compreensão da alocação dos recursos públicos em saúde (LIRA, 2010; ALVES *et al*, 2024). Ademais, estudos que possibilitem evidenciar as proporções e panoramas do que tem sido desenvolvido são fundamentais para auxiliar em reflexões e debates sobre o compromisso e avanços dos gestores para melhor atender as demandas de suas respectivas populações.

Diante disso, a presente pesquisa se justifica pela importância de se compreender os mecanismos de financiamento da saúde pública em um estado tão complexo e de relevância socioeconômica significativa para o Brasil: o Estado do Rio de Janeiro. Além disso, busca-se fornecer dados e evidências neste tema aplicado ao período de 2015 a 2018, no intuito de viabilizar análises e trabalhos futuros no cenário da tomada de decisão em saúde, a ser direcionado ao desenvolvimento de políticas públicas eficazes e com foco no atendimento universal e integral das diversas demandas da comunidade.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GERAIS

Apresentar o panorama da alocação de recursos em saúde do Estado do Rio de Janeiro, no período entre 2015 a 2018.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Demonstrar o perfil de alocação por cada bloco de financiamento em saúde, a fim de evidenciar áreas que receberam mais e menos recursos;
- Demonstrar a relevância da utilização de bancos de dados em saúde para proporcionar à população informações em suas diversas abrangências;
- Apresentar dados econômicos em saúde do cenário farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro (2015-2018) e as reflexões sobre o panorama levantado;
- Contribuir para o levantamento de evidências sobre o contexto do financiamento público das ações em saúde no Estado do Rio de Janeiro, bem como desafios e reflexões sobre esta temática.

4. MÉTODOS

Trata-se de um estudo quantitativo descritivo para melhor demonstrar o panorama e distribuição da transferência dos recursos públicos em saúde, no período de 2015 a 2018, no Estado do Rio de Janeiro, advindos do FNS. Utilizou-se a plataforma do Fundo Nacional de Saúde, sendo extraídos os valores totais de repasses por blocos de financiamento (FNS, 2023) e instrumentos regulatórios do Estado, dentre eles: o Plano Plurianual (2016-2019) (SEPLAG-RJ, 2016), Relatórios de Acompanhamento (REDEPLAN, 2023) e Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) (SEFAZ-RJ, 2024). A realização deste estudo ocorreu no segundo semestre de 2023.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado do Rio de Janeiro é o terceiro mais populoso do país, com, aproximadamente, 16 milhões de habitantes, conforme o último censo realizado em 2022. Com índice de desenvolvimento humano de 0, 762, é o oitavo maior em comparação aos demais estados brasileiros (IBGE, 2023). A economia do Estado, a segunda maior do país, chegou a representar 11,6% do PIB do Brasil em 2006 (SILVA, 2017). Sua relevância econômica está associada ao setor de serviços, indústria e, principalmente, às atividades petrolíferas referentes à exploração e produção de petróleo no litoral do Estado. É o maior produtor de petróleo, correspondendo a 84,15% da produção nacional, portanto a arrecadação dos royalties tem um papel fundamental nas finanças do Estado (RAPOSO, *et al*, 2023). A partir de dados do Portal da Transparência dos Royalties (SEFAZ-RJ, 2023) verifica-se que somente entre janeiro e julho de 2023 foram destinados mais de R$13 bilhões de receita dos royalties para o Estado, o que compreende 23,9% da receita total do Tesouro (SEFAZ-RJ, 2023).

No presente estudo foi realizada uma busca no site do FNS para extração dos valores totais de repasses por bloco de financiamento da saúde pública fluminense no período de 2015 a 2018 (Acesso: https://consultafns.saude.gov.br/#/consolidada). Adicionalmente, foi conduzida uma pesquisa no portal da Fazenda do Estado (Acesso: https://portal.fazenda.rj.gov.br/transparencia/) para obtenção dos RREOs e no portal Rede de Planejamento (REDEPLAN) (Acesso: https://www.redeplan.planejamento.rj.gov.br/planejamento.html#ldo) para extração do PPA e Relatórios de Acompanhamento (SEPLAG-RJ, 2016; REDEPLAN, 2023). Além da extração de dados, conforme mencionado, também foram realizadas leituras adicionais, a fim de complementar e compreender resultados presentes em estudos prévios (PAIM, 2013;

UNA-SUS, 2021; ANDRADE, *et al*, 2013; LINS, *et al*, 2021; LIMA, *et al*, 2020; SILVEIRA e GAIGER, 2021; PIOLA, *et al*, 2013; SCHNEIDER, *et al*, 2021; ALENCAR, *et al*, 2018; LOZARDO, *et al*, 2018).

Após a coleta, realizou-se a estratificação e tabulação dos valores, utilizando a ferramenta Google Sheets, com o objetivo de analisar e demonstrar o perfil de distribuição dos recursos públicos, advindos do FNS, por bloco de financiamento em saúde no Estado do Rio de Janeiro. Ressalta-se que não foram utilizados dados primários em saúde, não sendo necessária a apreciação deste estudo em Comitê de Ética e Pesquisa.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da coleta, tabulação e análise dos dados, verificou-se que o valor global dos recursos destinados ao Estado do Rio de Janeiro, advindos do FNS, foi de R$22.002.986.283,17 no período de 2015 a 2018. O quadro 1 apresenta os valores repassados pelo FNS a cada um dos blocos de financiamento ao Estado do Rio de Janeiro para o período mencionado, sendo destes R$480.758.737,56 alocados com a Assistência Farmacêutica e R$4.428.294.397,74 na Atenção Básica.

Quadro 1: Transferência de recursos públicos para a saúde no Estado do Rio de Janeiro entre 2015 e 2018.

Bloco de Financiamento em Saúde - FNS							
Ano	**Gestão do SUS**	**Assistência Farmacêutica**	**Atenção Básica**	**Vigilância em Saúde**	**Atenção Média e Alta complexidade e Especializada**	**Investimentos na Rede de Saúde**	**Total**
2015	R$ 870.300,00	R$ 116.969.157,47	R$ 950.195.524,08	R$ 160.035.980,96	R$ 3.678.260.109,07	R$ 105.454.799,15	R$ 5.011.785.870,73
2016	R$ 1.694.500,76	R$ 131.826.389,34	R$ 1.054.437.347,49	R$ 207.164.047,22	R$ 3.731.229.041,79	R$ 151.706.580,44	R$ 5.278.057.907,04
2017	R$ 1.325.000,00	R$ 110.776.527,08	R$ 1.070.678.203,99	R$ 183.858.122,06	R$ 4.011.418.852,27	R$ 82.737.459,74	R$ 5.460.794.165,14
2018	R$ 1.853.000,00	R$ 121.186.663,67	R$ 1.352.983.322,18	R$ 234.263.541,10	R$ 4.512.611.733,40	R$ 29.450.079,91	R$ 6.252.348.340,26
Total	R$ 5.742.800,76	R$ 480.758.737,56	R$ 4.428.294.397,74	R$ 785.321.691,34	R$ 15.933.519.736,53	R$ 369.348.919,24	**R$ 22.002.986.283,17**

Fonte: FNS, 2023. Acesso em: 07 nov 2023.

Com relação à consulta detalhada por blocos de financiamento, no portal FNS, observou-se que o bloco da Atenção básica apresentou um total de R$4.428.294.397,74, em outras palavras, 20,13% dos recursos destinados à saúde neste Estado entre 2015 a 2018. Adicionalmente, foram R$1.937.219.965,85 designados para o Piso da Atenção Básica (PAB) Fixo e R$2.491.074.431,89 ao PAB Variável, conforme exposto na tabela 1.

Tabela 1: Demonstração dos recursos destinados à Atenção Básica no período de 2015 a 2018.

Ano	Piso da Atenção Básica Fixo	Piso da Atenção Básica Variável	Total
2015	R$ 395.411.375,75	R$ 554.784.148,33	R$ 950.195.524,08
2016	R$ 464.640.941,37	R$ 589.796.406,12	R$ 1.054.437.347,49
2017	R$ 496.732.286,85	R$ 573.945.917,14	R$ 1.070.678.203,99
2018	R$ 580.435.361,88	R$ 772.547.960,30	R$ 1.352.983.322,18
Total	**R$ 1.937.219.965,85**	**R$ 2.491.074.431,89**	**R$ 4.428.294.397,74**

Fonte: FNS, 2023. Acesso em: 15 nov 2023.

No cenário da Assistência Farmacêutica, verificou-se que o Programa de Aquisição de Medicamentos Excepcionais obteve um total de R$113.013.489,99, o Farmácia Popular do Brasil teve um total de R$12.550.000,00, o Programa de Assistência Farmacêutica básica com R$348.358.789,24 dos recursos alocados e o Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS) um total de R$2.487.296,76. Adicionalmente, o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) teve R$2.966.743,17 e o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos recebeu um total de R$1.382.418,40, conforme mostra o quadro 2. Ressalta-se que a Assistência Farmacêutica representou 2,18% dos recursos repassados pelo FNS ao Estado do Rio de Janeiro, 0,03% para Gestão do SUS, 3,57% com Vigilância em Saúde, 72,42% com Média e Alta Complexidade e 1,68% referente às atividades de Investimentos na Rede de Saúde, considerando o período de 2015 a 2018.

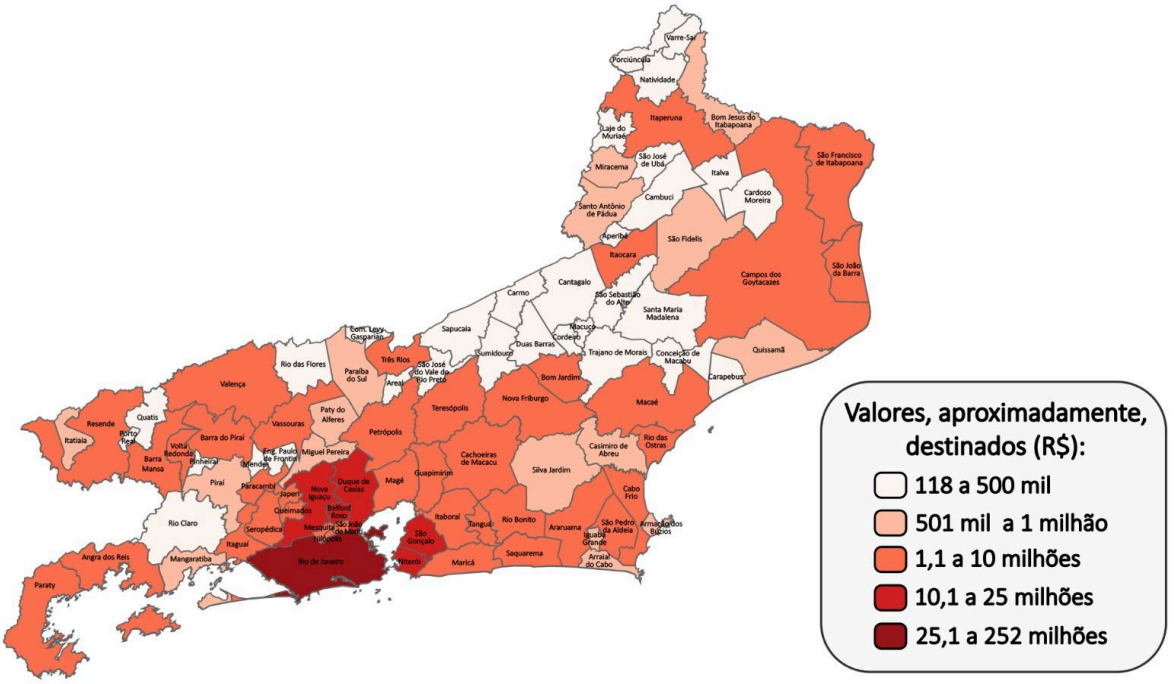
Quadro 2: Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica no período de 2015 a 2018 do Estado do Rio de Janeiro.

Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica no período de 2015 a 2018 - FNS							
Ano	**Prog. de aquisição de medicamentos excepcionais**	**Prog. Farmácia Popular do Brasil**	**Prog. de Assistência farmacêutica básica (Parcelas)**	**Prog. Nacional de Qualificação da Assist. Farmacêutica**	**Pessoas privadas de liberdade (PNAISP)**	**Programa Nacional de Plantas medicinais e Fitoterápicos**	**Total**
2015	R$ 33.359.992,40	R$ 5.212.500,00	R$ 76.470.076,10	R$ 234.000,00	R$ 1.326.008,97	R$ 366.580,00	R$ 116.969.157,47
2016	R$ 34.862.465,71	R$ 4.487.500,00	R$ 90.373.726,30	R$ 228.000,00	R$ 858.858,93	R$ 1.015.838,40	R$ 131.826.389,34
2017	R$ 20.294.563,29	R$ 2.850.000,00	R$ 86.616.088,52	R$ 234.000,00	R$ 781.875,27	ND	R$ 110.776.527,08
2018	R$ 24.496.468,59	ND	R$ 94.898.898,32	R$ 1.791.296,76	ND	ND	R$ 121.186.663,67
Total	R$ 113.013.489,99	R$ 12.550.000,00	R$ 348.358.789,24	R$ 2.487.296,76	R$ 2.966.743,17	R$ 1.382.418,40	**R$ 480.758.737,56**

Nota: ND = Não Disponível.
Fonte: FNS, 2023. Acesso em 15 nov 2023.

O mapa da figura 1 evidencia a heterogeneidade entre os valores repassados do FNS para a área da Assistência Farmacêutica em cada um dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. A região Norte Fluminense destinou um total de R$19.717.901,93, enquanto a região Centro-sul alocou R$6.983.447,89. Na região Metropolitana, os recursos foram de R$382.781.233,23, ao passo que na região Médio Paraíba foram registrados R$21.168.115,21. Além disso, a Baixada Litorânea recebeu R$17.121.966,11, a Costa Verde R$6.309.365,53, a região Serrana com R$19.333.606,56 e a região Noroeste com R$7.346.257,82 das verbas públicas destinadas a esta área.

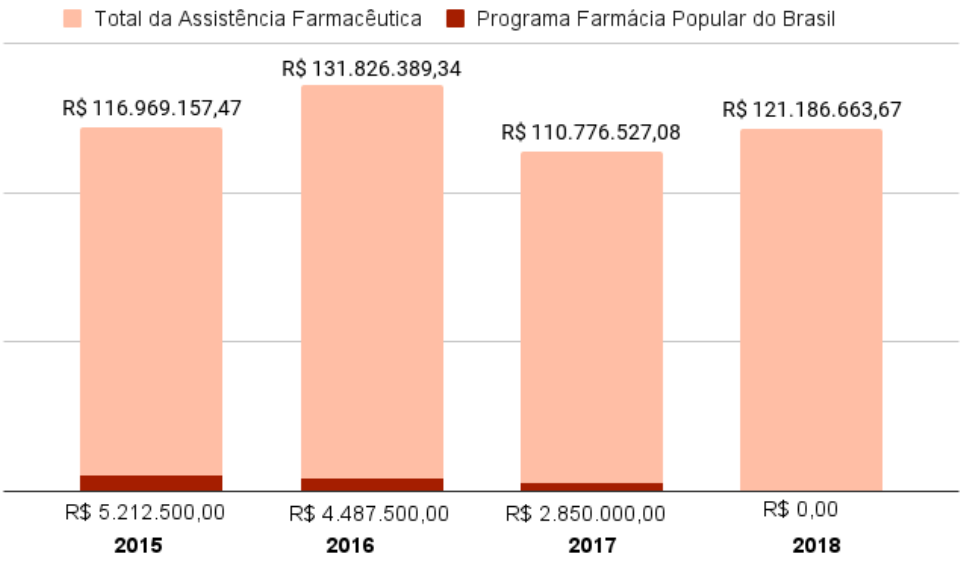
Figura 1: Recursos públicos destinados à Assistência Farmacêutica pelo Fundo Nacional de Saúde para municípios do Estado do Rio de Janeiro (2015-2018).



Fonte: FNS, 2023. Acesso em: 15 nov 2023.

Em 2015, o investimento no programa Farmácia Popular foi de R$5.212.500,00, seguindo para R$4.487.500,00 em 2016 e R$2.850.000,00 em 2017, conforme indica a figura 2.

Figura 2: Recursos públicos repassados do FNS as ações de Assistência Farmacêutica e ao Programa Farmácia Popular do Brasil no Estado do Rio de Janeiro (2015-2018)



Fonte: FNS, 2023. Acesso em: 15 nov 2023.

Acerca das ações estabelecidas no Plano Plurianual (2016-2019) (SEPLAG, 2016), bem como a análise dos Relatórios de Acompanhamento (REDEPLAN, 2023) e a Lei Orçamentária Anual (SEFAZ, 2024), foi possível extrair os valores executados no programa de Garantia da Assistência Farmacêutica. Os valores executados em relação ao previsto variaram durante o período: 67,54% em 2015, 52,99% em 2016, 140,32% em 2017 e 166,81% em 2018, como indicado na Tabela 2.

Tabela 2: Recursos destinados à Garantia da Assistência Farmacêutica no período de 2015 a 2018.

Ano	Valor executado	Valor previsto	Diferença Orçamentária
2015	R$164.431.393,87	R$243.450.046,00	- R$79.018.652,13
2016	R$89.774.020,57	R$169.407.944,00	-R$79.633.923,43
2017	R$161.672.142,30	R$115.218.388,00	+R$46.453.754,30
2018	R$155.924.886,46	R$93.475.352,00	+R$62.449.534,46
Total	**R$571.802.443,20**	**R$621.551.730,00**	**-R$49.749.286,80**

Fonte: Relatórios de Acompanhamento do Estado do Rio de Janeiro de 2015 a 2018, REDEPLAN. Acesso em: 15 nov 2023.

Conforme demonstrado por Lins e colaboradores (2021), apesar das fragilidades econômicas, o Brasil se esforça na promoção e oferta de serviços com o intuito de garantir a integralidade e gratuidade das ações em saúde para uma população que ultrapassa os 200 milhões de habitantes (LINS, *et al*, 2021). Embora a responsabilidade pelo financiamento do SUS seja tripartite, Lira (2010) aponta que é reservado ao Estado uma função adicional no suporte financeiro ao SUS, visando a complementação das ações, atuando de forma conjunta com as demais esferas. Diante dos avanços promovidos pelo SUS, torna-se necessário analisar o financiamento para otimizar as estratégias de planejamento e gestão em saúde, bem como a redução quantitativa das "perdas" associadas aos serviços ofertados à comunidade e a melhoria destes.

O Estado do Rio de Janeiro é um dos principais do Brasil e poucas são as publicações que demonstram o panorama dos recursos públicos destinados à saúde no cenário deste Estado (LIRA, 2010; BENEVIDES, 2010) e municípios envolvidos com este (ALVES, *et al*, 2024). Segundo Benevides (2010), a média de aplicação de recursos em saúde por habitante no Rio de Janeiro é superior à média nacional, mas isso não é refletido na prática, o que pode ser atribuído às deficiências na coordenação entre as três esferas de governo. No contexto da saúde pública, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ), o Estado dispõe de 3141 equipes de Saúde da Família, 380 hospitais gerais e especializados, e oferece serviços como Hemoterapia, Unidades de Alta Complexidade em Oncologia, Centros de Especialidades Odontológicas, Unidades de Pronto Atendimento (UPA-24h) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SES-RJ, 2023).

Muitos são os desafios e fragilidades enfrentados na saúde no cenário nacional e, em especial, no Estado do Rio de Janeiro, sendo um destes a falta de investimentos e/ou limitações orçamentárias. Alguns veículos de comunicação destacam, em suas reportagens, problemas na área da saúde no Estado, e buscam refletir e denunciar aspectos decorrentes da falta de alguns serviços, incluindo o sucateamento hospitalar (PRADO e GRAELL, 2023), escassez de medicamentos nas farmácias do governo (CASTRO, 2022) e irregularidades na Secretaria de Estado de Saúde (BRITO, 2020). A partir dos resultados encontrados, pôde-se verificar apenas para a área de Assistência Farmacêutica uma redução de mais de R$49 milhões, em outras palavras, uma quantia considerável de recursos deixaram de ser repassados e/ou direcionados a este Estado para ações como compra de medicamentos e serviços associados ao contexto farmacêutico. Com isso, pode-se destacar que a falta de

repasses pode estar associada a impactos diretos na vida do usuário do SUS, principalmente, os SUS dependentes, como a não oferta e/ou falhas/limitações na prestação de serviços.

Ao consultar o RREO é possível obter dados sobre o percentual de recursos próprios aplicados em ações e serviços de saúde por ano. Com base nele, verifica-se que em 2015, o Estado do Rio de Janeiro alocou 12,34%; no ano subsequente, 10,35%; em 2017, 12,22% e, em 2018, 12,16% (SEFAZ-RJ, 2024) dos recursos advindos de sua "receita" líquida com ações e serviços para a saúde. Considerando o mínimo de 12% estabelecido pela LC nº 141 de 2012 (BRASIL, 2012), o Estado cumpriu sua obrigação mínima em todos os anos, exceto em 2016. No entanto, ao ser comparado com outros estados, o Rio de Janeiro apresenta um desempenho inferior, por exemplo, durante o mesmo período, o Estado de São Paulo investiu, respectivamente, 12,50%, 13,19%, 13,24% e 13,36% de recursos próprios em saúde, acima do mínimo em todos os anos (SEFAZ-SP, 2024). Além disso, o Estado do Ceará foi o estado que mais investiu recursos próprios em saúde neste mesmo período, sendo 14,25% em 2015, 13,90% em 2016, 14,65% em 2017 e 15,40% em 2018 (CEARÁ, 2024), o que revela que mesmo tendo se destacado nos repasses em saúde, os percentuais não foram muito acima do mínimo exigido. Reforça-se que, infelizmente, União e Estado nem sempre cumprem o mínimo previsto referente ao repasse de verbas para a saúde, sobrecarregando, por sua vez, os municípios que precisam investir ainda mais, visto que muitos serviços de saúde são descentralizados, e a falta de financiamento estadual e federal pode afetar diretamente a prestação de serviços à população (PIOLA, *et al*, 2013).

No tocante aos governos municipais, de 2015 a 2018, a cidade que mais investiu, no Estado do Rio de Janeiro, foi Campos dos Goytacazes, com uma média de 54,1%, segundo dados divulgados do SIOPS (2024). Ressalta-se que o município de Campos dos Goytacazes é o mais populoso do Norte Fluminense, sendo reconhecido como um centro de referência em atendimentos de alta complexidade para esta região (BRASIL, 2007). Em contrapartida, ao analisar os municípios que menos investiram, nota-se que, em 2015, São João da Barra registrou 15%; em 2016, São João de Meriti atingiu 13,06%; em 2017, Quatis apresentou 15,09%; e em 2018, o município de Engenheiro Paulo de Frontin registrou 15%. Esses dados evidenciam as discrepâncias nos percentuais de investimento em saúde entre os municípios deste Estado e reforça a importância não apenas do cumprimento mas, principalmente, dos esforços do Estado e União em tentar contribuir de modo a melhor auxiliar os municípios em suas demandas em saúde.

Durante a análise do Estado do Rio de Janeiro de 2015 a 2018 no Portal do Fundo Nacional de Saúde, identificou-se um total executado de cerca de R$22 bilhões. É importante destacar que os repasses são realizados a partir de critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos (BRASIL, 1990; BRASIL, 2013). A partir dos resultados deste estudo, juntamente com toda relevância da Atenção Básica, que representa a porta de entrada do usuário ao SUS, foram observados que os recursos públicos, advindos do FNS, e repassados a esse Bloco de Financiamento foram de apenas 20,13% (FNS, 2023), o que se assemelha ao cenário nacional, que foi de equivalente a 21,7% (KLITZKE, 2022) para o mesmo período avaliado (2015-2018). Neste contexto, Schneider e colaboradores (2021) destacam que em países de alta performance em saúde, como Noruega e Austrália têm sido comum um sistema centrado na Atenção Básica, sendo importante para reduzir as desigualdades de acesso (SCHNEIDER, *et al*, 2021). Estudos revelam que o desinvestimento em Atenção Básica impede o fácil acesso da população aos serviços de saúde, sendo essencial o financiamento desta área, bem como investimentos na ampliação da cobertura vacinal, prevenção de agravos e ações com foco na promoção da saúde (OECD, 2020; KLITZKE, 2022).

A cobertura da Atenção Básica foi alvo de análises do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS), no qual foram considerados como indicadores a cobertura vacinal de poliomielite, a cobertura de pré-natal e o acesso aos serviços da Atenção Primária no ano de 2021. A pesquisa mostra que o Estado do Rio de Janeiro possui a pior taxa de cobertura, no qual apenas 57,2% da população possui acesso aos serviços de atenção básica, ficando em último lugar no ranking com as 27 unidades federativas do Brasil. A título de comparação, o Estado de São Paulo aparece na 26ª posição com uma taxa de 63,4% e o Ceará, o Estado que mais investiu em saúde de 2015 a 2018, encontra-se em 9º lugar com um percentual de 86,7% (IEPS, 2023).

Em relação ao Bloco da Assistência Farmacêutica, o Plano Plurianual (2016 a 2019) e os Relatórios de Acompanhamento (2015 a 2018) fornecem informações sobre os valores previstos e os executados, como os dados de 2015, o qual o Estado do Rio de Janeiro utilizou 67,54% (R$164.431.393,87) do total previsto no PPA. No ano seguinte, os gastos foram de 52,99% (R$89.774.020,57), com aumento significativo para 140,32% (R$161.672.142,30) em 2017 e, posteriormente, para 166,81% (R$155.924.886,46) em 2018. No geral, o valor total previsto a este bloco de financiamento foi de R$621.551.730,00, sendo apenas R$571.802.443,20 os recursos repassados, o que correspondeu a 92%. Essa distinção entre o

valor previsto e o executado destaca a importância de uma gestão cuidadosa e eficiente dos recursos na Assistência Farmacêutica. Ressalta-se que para garantir o acesso aos medicamentos do Componente Especializado, o estado do Rio de Janeiro contempla três farmácias estaduais de dispensação de medicamentos Especiais, 25 pólos municipais e dez Centros de Referência, resultantes da parceria com os municípios (SES-RJ, 2023).

Ainda no cenário farmacêutico, o programa Farmácia Popular merece destaque, visto que está contemplado dentre as atividades previstas em saúde no Estado do Rio de Janeiro desde a sua criação em 2004, e visa ampliar os serviços farmacêuticos e universalizar o acesso aos medicamentos (ALENCAR, *et al*, 2018; BRASIL, 2004). A partir dos resultados encontrados, este programa apresentou uma redução dos seus recursos financeiros de R$2.362.500,00, passando de R$5.212.500,00 para R$2.850.000,00 no período de 2015 a 2018, o que reflete o que ocorreu no cenário nacional, o qual passou de R$20 bilhões em 2015 para R$18,6 bilhões em 2016 (VIEIRA, 2018) associado ao encolhimento no gasto *per capita* em saúde, que saiu de R$1.610 em 2014 para R$1.552 em 2015 (COSTA, *et al*, 2022). Esse "corte" no financiamento deste programa, pode estar associado às restrições orçamentárias decorrentes da EC nº 95 de 2016, que congelou os gastos públicos por 20 anos, e resultou em uma perda orçamentária superior a R$22,5 bilhões (VIEIRA, 2018; COSTA, *et al*, 2022). Na prática, a estagnação do gasto público com saúde significou redução do número de consultas e leitos no SUS, salientando a desigualdade na oferta de serviços e restringindo o acesso (COSTA, *et al*, 2022).

Adicionalmente, de acordo com Orçamento Fácil, disponível no portal da transparência do Estado do Rio de Janeiro, os maiores gastos deste Estado direcionaram-se para a previdência social, enquanto a área da saúde ocupou a quinta posição em termos de despesas (SEFAZ-RJ, 2024). Lozardo e colaboradores (2018) destacam que a tendência de crescimento dos gastos com Previdência acaba comprimindo o orçamento das demais áreas, o que atrapalha na sustentabilidade e manutenção das despesas discricionárias como saúde, educação, segurança e infraestrutura, tornando-as mais suscetíveis a cortes (LOZARDO, *et al,* 2018). Em consulta ao PPA estadual (2016-2019), verifica-se que foram investidos cerca de R$3 bilhões no Programa Integrado de Mobilidade Urbana somente na região Metropolitana, a fim de reduzir engarrafamentos, enquanto apenas R$843,6 milhões foram direcionados para os serviços referente à Garantia da Assistência Farmacêutica no SUS/RJ, cujo objetivo é garantir o acesso a medicamentos e insumos (SEPLAG-RJ, 2016).

O estudo apresentou algumas limitações, dentre elas, a ausência de dados detalhados envolvendo cada bloco de financiamento, bem como a escassez de estudos prévios direcionados ao Estado do Rio de Janeiro, o que poderia possibilitar análises comparativas. Neste contexto, informações como a descrição quantitativa e qualitativa das áreas e suas respectivas atividades (exemplo: como, quando e com o quê?) referentes a cada um dos Blocos de Financiamento, não foram disponibilizadas no Portal do FNS. Apesar das limitações mencionadas, trata-se de um estudo inédito aplicado ao cenário do Estado do Rio de Janeiro direcionado ao financiamento das ações em saúde, referente aos repasses do FNS, no período de 2015 a 2018, e envolvendo um dos principais estados do Brasil, em especial, do ponto de vista socioeconômico, o que pode contribuir para as análises e reflexões sobre os desafios referentes à saúde pública não apenas para este Estado como para o país. Além disso, estudos como este reforçam a relevância do incentivo e valorização da realização de avaliações e reflexões, como as realizadas, uma vez que aborda e explora o uso de bancos de dados em saúde, como o FNS, os quais apresentam potencial de contribuir como ferramenta de gestão e fomentar análises imprescindíveis para o processo de tomada de decisão racional, transparente e eficiente.

6. CONCLUSÃO

A saúde pública é um pilar fundamental para o bem estar da população, refletindo diretamente na qualidade de vida e no desenvolvimento socioeconômico de uma nação. No contexto brasileiro, situações como restrições orçamentárias e a crescente demanda pelas ações e serviços em saúde são comuns e marcantes a qualquer uma das três esferas de gestão (união, estado e município), o que reforça a necessidade de um processo de tomada de decisão pautado na racionalidade e eficiência e, principalmente, com o compromisso para melhor atender as demandas do cidadão. Com isso, é crucial o entendimento e compreensão das demandas e prioridades de uma determinada localidade e/ou região, sendo indispensável esforços para garantir a oferta de serviços essenciais, além de aprimorar a infraestrutura da rede de atenção e serviços, em suas diferentes complexidades, e assegurar o acesso contínuo a medicamentos de qualidade.

Este estudo inédito apresentou o cenário da alocação de recursos direcionados ao Estado do Rio de Janeiro (2015-2018), a partir dos repasses advindos do Fundo Nacional de Saúde. Com base nas análises realizadas, observou-se que mudanças significativas na conjuntura econômica e política, reflexos da Emenda Constitucional nº 95 de 2016 (COSTA, *et al*, 2022) podem ter influenciado em alguns dos resultados encontrados, como a redução dos repasses previstos a áreas como Assistência Farmacêutica e Atenção Básica. O desinvestimento nos blocos da Atenção Básica e Assistência Farmacêutica, o que representou, respectivamente, 20,13% e 2,18% do valor total dos repasses em saúde, advindos do FNS, para este Estado. Adicionalmente, ressalta-se a relevância da transparência e facilidade de acesso aos dados como os obtidos e demonstrados, uma vez que fomenta discussões importantes no contexto da gestão, bem como da população (controle social).

A Assistência Farmacêutica e o Programa Farmácia Popular apresentam relevância para serviços como acesso de medicamentos à população, e representaram uma importante parcela dos recursos repassados pelo FNS ao Estado do Rio de Janeiro. Observou-se uma variação nos gastos com Assistência Farmacêutica no período estudado, o que resultou em uma "perda" orçamentária de R$49.749.286,80. Além disso, notou-se uma tendência de diminuição dos repasses, advindos do FNS, ao programa Farmácia Popular, reduzindo de R$5,2 milhões (2015) para R$2,8 milhões (2017), em apenas dois anos, o que pode comprometer e/ou prejudicar os usuários dependentes diretamente desses serviços. A falta de

dados para o ano de 2018 quanto aos gastos com o programa sugere a necessidade de um maior detalhamento para compreender as nuances desse período.

Em síntese, o debate em torno das fontes de financiamento do SUS reflete a complexidade e os desafios inerentes à gestão de um sistema de saúde universal e gratuito em um país de dimensões continentais e características socioeconômicas diversas. Encontrar soluções equilibradas que garantam o acesso universal sem comprometer a sustentabilidade financeira permanece como um objetivo essencial para fortalecer e aprimorar o sistema de saúde brasileiro.

7. REFERÊNCIAS

ALENCAR, T. Programa Farmácia Popular do Brasil: uma análise política de sua origem, seus desdobramentos e inflexões. Saúde debate. 2018; 42(2):159-172. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0103-11042018S211. Acesso em: 01 set 2023.

ALVES, N., et al. Alocação de recursos públicos para saúde em Macaé entre 2014 e 2017: Reflexões e Desafios. JAFF. 2024. Disponível em: https://ojs.jaff.org.br/ojs/index.php/jaff/article/view/811. Acesso em: 25 abr 2024.

ANDRADE M. et al. Desigualdade socioeconômica no acesso aos serviços de saúde no Brasil: um estudo comparativo entre as regiões brasileiras em 1998 e 2008. Economia Aplicada. 2013; 17(4): 623-645. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1413-80502013000400005. Acesso em: 04 ago 2023.

ARAÚJO, F.; FERNANDES, L. Lighting the populational impact of COVID-19 vaccines in Brazil. Fractals. 2022. 30(3)2250066. Disponível em: https://doi.org/10.1142/S0218348X22500669. Acesso em: 03 out 2023.

BENEVIDES, R. Financiamento do SUS na região metropolitana do Rio de Janeiro nos Anos 2000 [dissertação]. Rio de Janeiro: Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2010. Disponível em: https://www.bdtd.uerj.br:8443/bitstream/1/4465/1/Benevides%2c%20Rodrigo.pdf. Acesso em: 27 jan 2024.

BIDERMAN, C.; AVELINO, G. A doença da corrupção: o desvio de fundos e a saúde pública nos municípios brasileiros. FGV. 2013. Disponível em: https://periodicos.fgv.br/apgvpesquisa/article/view/58357/56830. Acesso em: 18 jun. 2024.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 2016. 496 p. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf\. Acesso em: 04 ago 2023.

BRASIL. Fundo Nacional de Saúde. FNS; c2023. Disponível em: https://portalfns.saude.gov.br/. Acesso em: 26 set 2023.

BRASIL. Fundo Nacional de Saúde. Sobre o FNS. 2024. Disponível em: https://portalfns.saude.gov.br/sobre-o-fns/. Acesso em: 05 jan 2024.

BRASIL. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro. Brasil: IBGE. c2023. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/panorama. Acesso em: 09 set 2023.

BRASIL. Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, Brasília, 2000. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm. Acesso em: 23 nov 2023.

BRASIL. Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Brasília, 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp141.htm. Acesso em: 23 nov 2023.

BRASIL. Lei nº 13.971, de 27 de dezembro de 2019. Institui o Plano Plurianual da União para o período de 2020 a 2023. Brasília. 2019 . Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13971.htm. Acesso em: 15 nov 2023.
BRASIL. Lei Orgânica nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm\. Acesso em: 04 ago 2023.

BRASIL. Lei Orgânica nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Brasília, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm\. Acesso em: 04 ago 2023.

BRASIL. Ministério da Economia. Relatório anual de monitoramento - Plano Plurianual. Ano-base 2021. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/plano-plurianual/arquivos/monitoramento/relatorio-anual-de-monitoramento.pdf. Acesso em: 15 nov 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. 1º Seminário de Gestão Participativa em Saúde da Região Norte do Rio de Janeiro. Brasília. BVSMS; 2007. 78 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/07_0190_M.pdf. Acesso em: 27 jan 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Calendário Nacional de Vacinação. 2023. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao. Acesso em: 31 out 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde recomenda ampliação de recursos para o SUS e garantia do piso constitucional. 2023. Disponível em: https://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/3155-conselho-nacional-de-saude-publica-recomendacao-para-a-uniao-manter-e-ampliar-o-piso-de-investimentos-no-setor. Acesso em: 06 nov 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Esquemas vacinais. 2023. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/coronavirus/vacinas/esquemas-vacinais. Acesso em: 08 nov 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Nova estratégia de vacinação contra Covid-19 começa a valer em 1º de janeiro. 2023. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/dezembro/nova-estrategia-de-vacinacao-contra-covid-19-comeca-a-valer-em-1o-de-janeiro. Acesso em: 10 jan 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.651, de 11 de agosto de 2004. Dispõe sobre o modelo de gestão do Programa Farmácia Popular do Brasil, e dá outras providências. 2004. Brasília. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt1651_11_08_2004.html#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20modelo%20de,que%20lhe%20confere%20o%20art. Acesso em: 20 jan 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 204 de 29 de janeiro de 2007. Regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde. Brasília, 2007. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt0204_29_01_2007_comp.html. Acesso em: 15 nov 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3992 de 28 de dezembro de 2017. Altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt3992_28_12_2017.html. Acesso em: 15 nov 2023

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 53, de 16 de janeiro de 2013. Estabelece diretrizes para o funcionamento do SIOPS e fixa prazos para registro e homologação de informações. Brasília; 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0053_16_01_2013.html. Acesso em: 20 jan 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde. Maior sistema público de saúde do mundo, SUS completa 31 anos. 2021. Disponível em: https://www.unasus.gov.br/noticia/maior-sistema-publico-de-saude-do-mundo-sus-completa-31-anos. Acesso em: 01 set. 2023.

BRASIL. Secretaria de Relações Institucionais. Sistemas de Informações do Fundo Nacional de Saúde. 2024. Disponível em: https://www.gov.br/sri/pt-br/backup-secretaria-de-governo/portalfederativo/agenda-do-prefeito-brasil/guiatermino/areas-tecnicas/saude/sistema-do-fundo-nacional-de-saude#FNS. Acesso em: 05 jan 2024.

BRASIL. Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. SIOPS. Indicadores Municipais - R. Próprios em Saúde - EC29 segundo municípios. RJ. DATASUS. Disponível em: http://siops-asp.datasus.gov.br/CGI/tabcgi.exe?SIOPS/serhist/municipio/indicRJ.def. Acesso em 27 jan 2024.

BRITO, C. Relatório da Controladoria-Geral do Estado aponta 45 irregularidades na Secretaria de Saúde do RJ. G1. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/24/relatorio-da-controladoria-geral-do-estado-aponta-irregularidades-na-secretaria-de-saude-do-rj.ghtml. Acesso em: 20 jan 2024.

BRITO, S.; SOBREIRA, F. A evolução nos gastos públicos com a saúde no município de Jaru/RO, juntamente com os recursos repassados: breve análise dos anos de 2017 a 2018. Jaru FIMCA; 2019. Disponível em: https://jaru.fimca.com.br/gerenciador/data/uploads/2022/01/A-EVOLUCAO-NOS-GASTOS-PUBLICOS-COM-A-SAUDE-NO-MUNICIPIO-DE-JARU-JUNTAMENTE-COM-OS-RECURSOS-REPASSADOS-BREVE-ANALISE-DOS-ANOS-DE-2017-A-2018-2019.pdf. Acesso em: 27 jan 2024.

CASTRO, N. Pacientes sofrem com falta de remédios nas farmácias do governo e particulares no RJ. G1. 2022. Disponível em:

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/07/15/pacientes-sofrem-com-falta-de-remedios-nas-farmacias-do-governo-e-particulares-no-rj.ghtml. Acesso em: 20 jan 2024.

CEARÁ (Estado). Portal Ceará Transparente. Relatório Resumido de Execução Orçamentária (2015-2018). 2024. Disponível em: https://cearatransparente.ce.gov.br/portal-da-transparencia/paginas/relatorio-resumido-da-execucao-orcamentaria?__=__. Acesso em: 01 fev 2024.

CEPERJ. Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de servidores públicos do Rio de Janeiro. Produto Interno Bruto dos Municípios. 2020. Disponível em: http://arquivos.proderj.rj.gov.br/sefaz_ceperj_imagens/Admin/Uploads/PIB-MUICIPIOS-DEZ-2020_(1).pdf. Acesso em: 05 jan 2024.

COSTA, D. et al. Crise econômica e disparidades no gasto, oferta e utilização de serviços públicos e privados de saúde no Brasil no período entre 2011 e 2019. Cad. Saúde Pública. 38(10). 2022. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csp/a/3vpqJkVYbsh8PB9KNvcyqjd/?lang=pt#. Acesso em: 10 jan 2024.

FERNANDES, G.; PEREIRA, B. Os desafios do financiamento do enfrentamento à COVID-19 no SUS dentro do pacto federativo. Revista de administração pública. 2020. 54(4)595-613. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/0034-761220200290. Acesso em: 01 set 2023.

FIGUEIREDO, J. et al. Gastos público e privado com saúde no Brasil e países selecionados. Saúde Debate. 2018. 42(2), 37-47. Disponível em: https://www.scielo.br/j/sdeb/a/hbzwsvZnS7PbVJsXsfWJSfB/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 15 nov 2023.

FIOCRUZ. Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz - Antonio Ivo de Carvalho. Portaria do Ministério da Saúde que dá autonomia a gestores locais desestrutura o SUS. 2018. Disponível em: https://cee.fiocruz.br/?q=portaria-do-ministerio-da-saude-que-da-autonomia-a-gestores-locais-desestrutura-o-sus. Acesso em: 20 jan 2024.

HOMMA, A. et al. Vacinas e vacinação no Brasil: Horizontes para os próximos 20 anos. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz. 2020. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/handle/icict/45003/Livro%20Vacinas%20no%20Brasil-1.pdf?sequence=2. Acesso em: 05 nov 2023.

INSTITUTO DE ESTUDOS PARA POLÍTICAS DE SAÚDE. Rio de Janeiro tem a pior cobertura da Atenção Básica do país, revela boletim IEPS Data. 2023. Disponível em: https://ieps.org.br/rio-de-janeiro-tem-a-pior-cobertura-da-atencao-basica-do-pais-revela-boletim-ieps-data/#:~:text=O%20estado%20alcan%C3%A7ou%20apenas%2055,Par%C3%A1%20(56%2C8%25). Acesso em: 18 jun. 2024.

KLITZKE, D. Quanto o Brasil investe em Atenção Primária à Saúde? Blog Segundeira da APS. 2022. Disponível em: https://atencaoprimaria.com.br/quanto-o-brasil-investe-em-aps-2/. Acesso em: 20 jan 2024.

LIMA, L. et al. Plano Plurianual como Proxy para medir capacidades estatais: um estudo sobre o planejamento governamental nos municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Rev. Bras. Gest. Urbana. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2175-3369.012.e20190147. Acesso em: 15 nov 2023.

LINS, J. et al. O SUS e a atenção primária no Brasil: uma análise sobre o seu financiamento pelo piso da atenção básica fixo. Planejamento e Políticas Públicas. 2021. (55). Disponível em: //www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/1130. Acesso em: 15 nov 2023.

LIRA, A. A instância estadual e o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) sob a perspectiva da equidade regional: estudo do caso do Rio de Janeiro. [dissertação]. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz. 2010. 140 p. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/2440. Acesso em: 15 nov 2023.

LOZARDO, E. et al. O crescimento insustentável dos gastos com Previdência e Pessoal. Carta de Conjuntura. 2018. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/180215_CC38_gasto_previdencia.pdf. Acesso em: 20 jan 2024.

OECD. Realizing the potential of primary health care - Primary health care in low- and middle-income countries. 2020. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5a3b7d49-en/index.html?itemId=/content/component/5a3b7d49-en. Acesso em: 20 jan 2024.

PAIM, J. A Constituição Cidadã e os 25 anos do Sistema Único de Saúde (SUS). Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro. 2013. v.29, n.10, p.1927-1936. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0102-311X00099513. Acesso em: 04 ago 2023.

PIOLA, S. et al. Estruturas de financiamento e gasto do sistema público de saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz. 2013. Disponível em: https://books.scielo.org/id/z9374/pdf/noronha-9788581100180-03.pdf. Acesso em: 15 nov 2023.

PRADO, A.; GRAELL, F. Relatório do Ministério da Saúde aponta problemas em hospitais federais no RJ; cirurgia pode levar até 9 anos. G1. 2023. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/07/26/relatorio-do-ministerio-da-saude-aponta-problemas-em-hospitais-federais-no-rj-cirurgia-pode-levar-ate-9-anos.ghtml. Acesso em: 20 jan 2024.

RAPOSO, C. et al. Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento. Royalties do Petróleo. TCM-RJ. 2023. Disponível em: http://www.tcmrio.tc.br/noticias/3072/01roya~1.pdf. Acesso em: 13 set 2023.

RIO DE JANEIRO (Estado). REDEPLAN. Instrumentos de Planejamento. Relatórios de Acompanhamento PPA 2012-2015 e 2016-2019. 2023. Disponível em: https://www.redeplan.planejamento.rj.gov.br/planejamento.html#ldo. Acesso em: 15 nov 2023.

RIO DE JANEIRO (Estado). SEPLAG-RJ. Plano Plurianual 2016-2019. RJ: PPA. 2016. Disponível em: https://portal.fazenda.rj.gov.br/transparencia-fiscal/wp-content/uploads/sites/15/2023/11/ppa2016-2019_vol2.pdf. Acesso em 27 jan 2024.

RIO DE JANEIRO (Estado). SEFAZ-RJ. Portal da Transparência. Orçamento Fácil - Função. 2024. Disponível em: https://tfe.fazenda.rj.gov.br/tfe/web/orcamentofacil. Acesso em: 20 jan 2024.

RIO DE JANEIRO (Estado). SEFAZ-RJ. Portal Transparência Fiscal. LOA: 2015 - 2018. 2024. Disponível em: https://portal.fazenda.rj.gov.br/transparencia-fiscal/ppa-ldo-loa/. Acesso em: 31 jan 2024.

RIO DE JANEIRO (Estado). SEFAZ-RJ. Recursos do petróleo - Portal da Transparência dos Royalties do petróleo e das participações especiais. 2023. Disponível em: https://portal.fazenda.rj.gov.br/petroleo/receita/2023-2/. Acesso em: 09 set 2023

RIO DE JANEIRO (Estado). SEFAZ-RJ. Secretaria de Estado da Fazenda. Relatórios Fiscais. 2024. Disponível em: https://portal.fazenda.rj.gov.br/contabilidade/relatorios-fiscais/. Acesso em: 20 jan 2024.

RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria de Estado de Saúde. SES-RJ. Plano de Saúde Estadual 2020-2023. 2023. Disponível em: https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=NDI1NTY%2C. Acesso em: 15 nov 2023

RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria de Estado de Saúde. SES-RJ. Retrospectiva 2022: Secretaria de Estado de Saúde investe para levar a saúde para mais perto da população. 2022. Disponível em: https://saude.rj.gov.br/noticias/2022/12/retrospectiva-2022-secretaria-de-estado-de-saude-investe-para-levar-a-saude-para-mais-perto-da-populacao#:~:text=Sa%C3%BAde%20RJ%20%2D%20Not%C3%ADcias%20%2D%20Retrospectiva%202022,para%20mais%20perto%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o&text=Sa%C3%BAde%20mais%20perto%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o,R%248%20bilh%C3%B5es%20em%20sa%C3%BAde. Acesso em: 26 set 2023.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado. Relatório Resumido da Execução Orçamentária. 2024. Disponível em: https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Relat%C3%B3rio-Resumido-da-Execu%C3%A7%C3%A3o-Or%C3%A7ament%C3%A1ria.aspx. Acesso em: 10 jan 2024.

SCHNEIDER, E. et al. Mirror, Mirror 2021: Reflecting Poorly - Health care in the U.S. Compared to other high-income countries. The Commonwealth Fund. 2021. Disponível em: https://www.commonwealthfund.org/sites/default/files/2021-08/Schneider_Mirror_Mirror_2021.pdf. Acesso em: 20 jan 2024.

SILVA, E. Evolução da economia do estado do Rio de Janeiro na segunda década do século XXI. 2017. Disponível em:

https://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/35279/evolucao_economia%20_fernandez.pdf?sequence=1. Acesso em: 09 set 2023.

SILVEIRA, F.; GAIGER, M. O gasto em saúde e suas bases de financiamento: Dinâmica e tendências para o Brasil. 2021. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/52125. Acesso em: 15 nov 2023.

SINFRERJ. Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio de Janeiro. Estudo mostra que Rio de Janeiro recupera atividade econômica. 2022. Disponível em: https://sinfrerj.com.br/conteudo/785/estudo-mostra-que-rio-de-janeiro-recupera-atividade-economica. Acesso em: 26 set 2023.

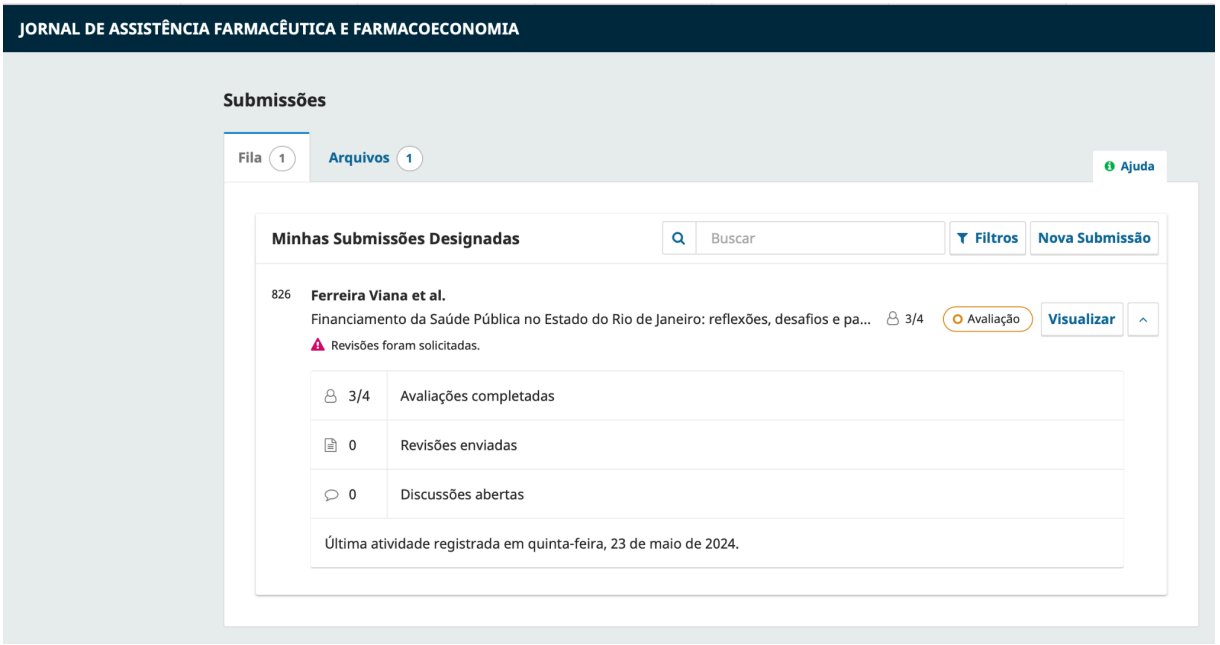
TRECE, J. Estado do Rio é o que menos cresceu desde 1985. Blog IBRE - Fundação Getúlio Vargas. 2022. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/estado-do-rio-e-o-que-menos-cresceu-desde-1985. Acesso em: 26 set 2023.

UGÁ, M. et al. Descentralização e alocação de recursos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Ciênc. saúde coletiva. 2003. 8(2)417–437. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/H5rJSdQbbNJG7c6Z8RLkm9L/abstract/?lang=pt#. Acesso em: 15 nov 2023.

UGÁ, M. et al. Financiamento e Alocação de Recursos em Saúde no Brasil. Políticas e sistema de saúde no Brasil. 2012. Disponível em: https://books.scielo.org/id/c5nm2/pdf/giovanella-9788575413494-19.pdf. Acesso em: 15 nov 2023.

VIEIRA, F. Evolução do gasto com medicamentos do sistema único de saúde no período de 2010 a 2016. IPEA. 2018. Disponível em: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/177572/1/td_2356.pdf. Acesso em: 20 jan 2024.

VIEIRA, F. Avanços e desafios do planejamento no Sistema Único de Saúde. Ciência & Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, v.14, n.1, p.1565-1577, 2009. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1413-81232009000800030. Acesso em: 04 ago 2023.

8. APÊNDICE

Submissão do artigo no Jornal de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia